

Arrêt cardiaque en sauveteur isolé

Lorsque la victime a perdu connaissance et ne respire pas, ou que la respiration est anormale, et que le secouriste se retrouve seul et sans matériel, il convient d'appliquer la conduite à tenir suivante :

- **si aucun tiers n'est présent :**
 - alerter les secours :
 - avec un téléphone portable, si vous disposez du mode haut-parleur, l'activer et débiter immédiatement la RCP en même temps que vous alertez ;
 - en l'absence de téléphone ou de réseau, quitter la victime pour aller alerter puis revenir auprès de la victime.
 - si un DAE est proche¹ :
 - le mettre en œuvre le plus tôt possible et suivre ses indications vocales ;
 - interrompre le massage cardiaque le moins possible.
- **si un tiers est présent**, lui demander d'alerter² les secours et de ramener et installer un DAE ;
- débiter immédiatement³ une RCP en répétant des cycles de :
 - **adulte** : 30 compressions thoraciques / 2 insufflations⁴ ;
 - **enfant et nourrisson** : 15 compressions thoraciques / 2 insufflations⁴.
- **si un DAE est installé**, reprendre la RCP immédiatement après la délivrance, ou non, d'un choc électrique sans attendre ses instructions vocales ;
- poursuivre la RCP jusqu'à une demande d'interruption par le DAE ou le relais par les services de secours.

Si plusieurs intervenants formés sont présents, et si possible, se relayer pour la RCP lors des analyses du DAE ou toutes les 2 minutes environ. Dans le but de garantir l'efficacité des manœuvres, un de ces intervenants formés peut assurer le rôle de « coach » en guidant, encourageant et corrigeant les gestes effectués par les autres.

En période d'épidémie⁵ adapter la conduite à tenir comme suit

- se protéger, si possible, avec un masque ;
 - apprécier la respiration⁶ de la victime en regardant si son ventre et sa poitrine se soulèvent ;
 - **si possible, placer⁷ un tissu, une serviette ou un masque sur la bouche et le nez de la victime ;**
 - **effectuer seulement des compressions thoraciques ;**
- Concernant le bouche-à-bouche, deux situations sont laissées à l'appréciation du sauveteur :**
- le sauveteur vit sous le même toit que la victime (risque de contamination déjà présent) ;
 - la victime est un enfant ou un nourrisson.
- se tenir au pied de la victime lors de l'administration du choc ;
 - dès que possible, se laver soigneusement les mains à l'eau et au savon ou avec une solution hydroalcoolique ;
 - appliquer les consignes sanitaires nationales.

¹ Le sauveteur récupère lui-même le DAE s'il est à proximité, facilement accessible, et qu'il peut se le procurer immédiatement sans quitter la victime plus de 10 secondes. Dans le cas contraire, le sauveteur réalise la RCP jusqu'à ce qu'on lui apporte le DAE.

² Le service de secours appelé pourra aider le sauveteur à la réalisation de la RCP, en donnant des instructions téléphoniques.

³ Toute action entreprise par le sauveteur ne doit pas retarder, empêcher ou interrompre la RCP.

⁴ Si les insufflations ne peuvent pas être effectuées (répulsion, maladie infectieuse et contagieuse, vomissements, traumatisme majeur de la face, etc.), il doit réaliser uniquement les compressions thoraciques en continu à un rythme de 100 à 120 compressions par minute.

⁵ Lors d'une épidémie engendrant une maladie infectieuse contagieuse par transmission respiratoire.

⁶ Ne pas procéder à la bascule de la tête de la victime en arrière, ne pas tenter de lui ouvrir la bouche, ne pas se pencher au-dessus de la face de la victime et ne pas mettre son oreille et sa joue au-dessus de la bouche et du nez de la victime ;

⁷ Avant de procéder aux compressions thoraciques et à la défibrillation.